23. 肝脏触诊前的实践注意事项

时长：06:13 教学单

课程总结

在本次课程中，学员将学习如何探索肝脏，同时考虑到其在整个身体中的整合及其与心脏和周围结构的关系。胚胎运动的概念是实践的核心，技术将从一个中立的接触开始，然后逐步深入，从而促进原发性呼吸和治疗过程的出现。学员将获得指导，了解与胚胎支点（特别是中线和心脏）协同工作的重要性，以激活血管和神经系统，从而提高治疗的有效性。

触及肝脏前的练习

在本次课程中，我们将探讨**肝脏**与其**整体环境**的关系。重要的是不要采取过于**选择性**或**局部性**的方法。

肝脏在**网膜囊**的组织、**胃**的定位、**脾脏**轴线和**大网膜**中起着核心作用。我们将对肝脏进行操作，同时考虑到它与**心脏**和网膜囊的关系，并采用适当的手法。

目标是让肝脏恢复其**自发运动**，因为正是这种自发运动创造了其功能。我们将从**中性**和表面的接触开始，随着**原发性呼吸**的显现，接触将逐渐深入。这两个中性的相遇促成了**治疗过程**的出现。

肝脏在胚胎组织中至关重要，尤其是在**横向**轴线和**胃-十二指肠-胰腺-脾脏**轴线的定位中，从而管理着所有的运动。我们之前讨论过的**静脉**和**动脉**网络所涉及的这种倾斜，是生长发育中必不可少的运动。肝脏在自身上移动，不是通过旋转，而是通过**位移**，这赋予了它发展的力量。

这种源于胚胎的自发运动是基础。当我们放置双手时，我们必须将自己置于一个**支点**中，让整个系统得以发展。如果我们将自己局限于局部方法，我们就会失去对原始支点的认识。

我们越接近胚胎支点，就越能获得这种力量，身体也能为我们提供更多信息，因为它了解这些信息。高频率有利于**再生能力**。将“支点”一词视为一种**功能**，而不仅仅是一个支撑点。

例如，**中线**是整体的支点。我们将心脏区域确定为胚胎支点，它不能被简化为一个简单的点。

与**大脑**发育相关的自发运动工作可以作为一种工具。回想一下大脑的弯曲，这种大脑的“太极”：

- **扩张**
- **头屈**
- **颈屈**
- **脑桥屈**
- **端脑化**

端脑化阶段至关重要，因为它诱导了**前白线**的伸直和定位。这涉及到**星形结构**的形成。

我们可以只关注自发运动，或者使用**特定点**，例如：

- **单丘体**尖端
- **枕骨上部**
- **枕骨**底部
- **蝶骨前部**

这些点与这些发展相关。例如，单丘体尖端是**中脑下屈曲**中的一个重要参考点。

因此，我可以根据我所定位的支撑点，在发育中的系统中寻找**寂静点**。某些阶段将同时进行，这说明了发育的**同步性**。

关于大脑发育，一个重要的遗迹位于**肠系膜系统**。**卵黄**或**肠系膜**轴对于重新激活发育中的大脑至关重要。

在血管方面，值得注意的是，大脑的功能和形成完全依赖于心脏。心脏不断地向大脑传递信息，大脑中存在**搏动**。

请记住**横膈膜**的图像，它随着肝脏的定位而卷曲，并与**卵黄囊**整合。**羊膜腔**的定位是我们之前工作的结果。

肝脏产生了一种发育性的自发运动，它组织着整个**肝-胃-十二指肠-胰腺-脾脏**系统。我们观察到心脏在其左轴上的倾斜，肝脏整体层面的反向运动，以及消化层面的反向旋转。

我们首先将处理这个**膈下**的大型组织中心，定位网膜囊。然后，我们将检查肝脏和心脏之间的关系，这将是我们的两个工作点。

我们有**心脏印记**、**肺部印记**和巨大的**肝脏印记**。我们将对肝脏进行操作，使其与心脏和肠道的定位相关联，采用**生物动力学**方法。

这意味着我们将放置双手，让运动自然发生。我们可能会有一个寻求的运动，或者一个表达其原始性的运动。我们将提供这一点，以便系统能够重新组织。

肝脏是一种**特化**，可以被视为肠道的**分形扩张**。它由一组**胆管**组成，包含两种类型的信息：

- **血管**类型的信息，对应于**门静脉**型肝脏。
- 全红的脸可能表明**中胚层**型肝脏问题。
- 全黄的脸可能表明**内胚层**型肝脏问题。

这两种方法可以互补地理解系统。